

医知創造ラボ

手のふるえ、 薬が効かなかったら？

本態性振戦の治療を
2026年の研究で整理

次の診察で、何を相談する？

最初の薬で、終わりではありません

1 診断をもう一度
ふるえの経過・ほかの薬

2 効果と副作用
生活が楽になったか

3 次の選択肢を相談
薬の見直し・専門施設

ふるえの「変化」を伝える

A いつ・どんなとき？
始まった時期／動作中・安静時

B 薬や体調に変化は？
市販薬・サプリも一覧に

! 急な変化は別に対応
麻痺・言葉の異常が突然なら救急要請

- 効果を見る

同じ動作で、比べてみる

01

文字を書く

名前を書いた紙を
日付と一緒に保存

02

コップを持つ

こぼしやすさや
持ちやすさを確認

03

食事をする

食具の使いやすさ
食事の負担を記録

「効き目」と「つらさ」を分ける

困りごと

診察で伝えること

ふるえが変わらない

飲み方・期間・困る動作

効くが、続けにくい

眠気・ふらつき・だるさ

生活への影響

転倒・仕事・運転への不安

自己判断で増量・中断せず、医師・薬剤師へ。

薬の選び方には、個人差があります

1 アロチノロール

国内で本態性振戦の適応あり

2 海外の推奨は別に確認

プロプラノロール・プリミドンなど

3 持病・副作用・希望で相談

適応・保険・供給は、それぞれ確認

■ 次の選択肢

薬を増やせないときにも、
相談できる選択肢があります

専門施設への相談は、
手術を決めることではありません。

- 専門施設で検討する治療

仕組みと、その後の管理が違います

観点	DBS:脳深部刺激療法	FUS:集束超音波
方法	電極で脳を刺激	熱で標的を治療
治療後	刺激を調整・機器管理	治療した変化は戻せない
確認する点	歩行・発語などへの影響／希望や体の状態	

この2剤は、別の薬です

薬剤名	確認できた報告
suvecaltamide	第2b相・査読原著 主要評価項目は未達
ulixacaltamide	第3相・学会抄録 主要評価項目を達成と報告

試験の結果を直接比べることはできません。

「根拠不十分」は「無効」と違います

1 確かさが足りない

効かないと証明された、とは別

2 薬物療法のレビュー

4週以上の試験／検索は2024年4月まで

3 審査中と承認済みは別

日本で使えるかも、別に確認

- 次の診察に持っていく

「何をできるようにしたいか」も伝える

困る動作

文字・コップ・食事など

薬と変化

薬名・時刻・効果・副作用

自分の希望

仕事を続けたい／食事を楽にしたい

「効かない」の一言を、次の相談につなげましょう。

医知創造ラボ

次の診察で、 相談してみてください

個々の治療方針は、担当医と相談を。

チャンネル登録

高評価

次回の動画もお楽しみに